



VENERE

Il primo operatore nazionale della medicina estetica in Italia

Buy-and-build nel settore più frammentato e in crescita della sanità privata pay-per-service — e un dataset clinico proprietario che, nel tempo, industrializza la qualità e riduce la dipendenza dal medico.

L'OPPORTUNITÀ

Un mercato grande, senza un proprietario, con la finestra aperta

800k+

procedure l'anno in Italia
(500k non chirurgiche,
300k interventi)

90%+

studi indipendenti e mono-
medico: nessuna catena
domina

0

consolidatori buy-and-build
con capitale istituzionale
oggi

3-4x

EBITDA d'ingresso, spesso
in uscita generazionale

L'Europa è già partita

UK: sk:n e Harley Medical aggregate. Il capitale istituzionale arriverà anche in Italia — chi costruisce prima detta i prezzi.

Vento GLP-1

I farmaci per la perdita di peso creano domanda ricorrente: rimodellamento e skin quality post-dimagrimento.

Ricambio generazionale

Titolari verso la pensione senza successori: venditori motivati, aperti a earn-out e permanenza clinica.

È la fotografia del dentale e delle farmacie italiane prima del consolidamento. Ogni trimestre di attesa alza i multipli.

Il modello ha già vinto: USA medspa, dentale e farmacie italiane

USA · Medspa — la scala paga

- ◆ Studio mono-medico 3-6x EBITDA; piattaforma recurring 30%+ a 7-12x
- ◆ I membri valgono 4,8x il lifetime value e spendono +35% a visita
- ◆ 2026 anno record M&A: LaserAway in vendita >2 mld \$

Italia · Sanità-retail — già eseguito qui

- ◆ Stessa struttura: mono-professionista, contabilità artigianali, zero brand
- ◆ Dentale (DentalPro) e farmacie (Hippocrates): da studi grigi a catene nazionali via PE
- ◆ Vince M&A disciplinato + trasformazione operativa, non la tecnologia

La medicina estetica ha 3 vantaggi strutturali: 100% pay-per-service senza convenzioni, ricorrenza naturale 3-4 visite/anno, margini lordi superiori sugli iniettabili.

Due motori: arbitraggio dei multipli e trasformazione del formato



Compriamo **flussi di cassa esistenti** (rischio d'impresa già pagato dal venditore) e li trasformiamo con un formato replicabile. Anche senza espansione dei multipli, la sola crescita dell'EBITDA per clinica e l'effetto scala generano ritorno: **l'arbitraggio è il moltiplicatore, non la scommessa.**

Sei caratteristiche: cosa cambia in ogni clinica acquisita

Recurring su prescrizione

Percorsi programmati a pagamento mensile + membership. Target 15-20% ricavi ricorrenti a 24 mesi, 30% a regime.

Multi-provider by design

2+ medici e protocolli condivisi: il paziente è fedele al brand e al percorso, non al singolo.

Mix clinico completo

Iniettabili, energy-based, rigenerativa, post-GLP-1: più categorie e più visite per paziente.

Patient journey da retail

Beauty advisor, consulenza strutturata, follow-up e recall automatici: esperienza premium.

Pagamenti rateali

Rateizzazione a tasso zero: alza il ticket e apre la fascia 25-40, già abituata al buy-now-pay-later.

Gestione manageriale

GM di area, KPI settimanali (saturazione, conversione, retention), procurement e marketing centrali.

Ogni elemento è già validato nel mercato USA; l'insieme non esiste ancora in nessuna clinica italiana.

La formalizzazione è il motore del valore, non un costo

Il settore è frammentato, a pagamento e in gran parte informale: **è proprio questo a deprimere i multipli d'ingresso**. Chi porta trasparenza cattura il re-rating — come nel dentale/diagnostica in Brasile e India (da studi grigi a piattaforme premium).

Rate = tracciabilità

Il pagamento mensile su carta/finanziaria rende il ricavo bianco e allarga il mercato. Formalizzi crescendo.

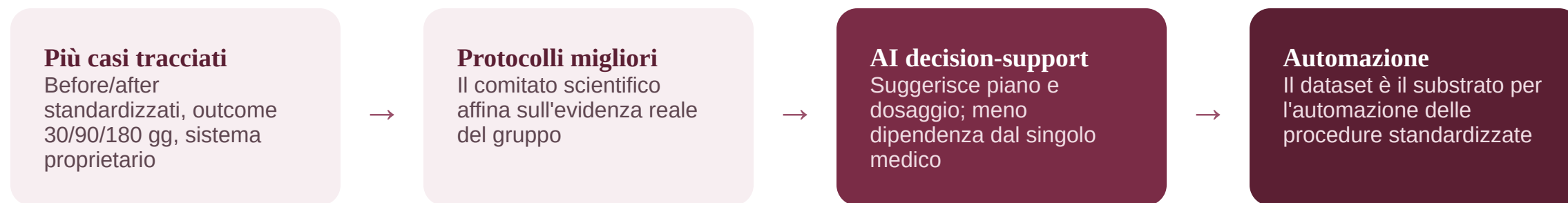
Rollover in equity

Il medico converte reddito da lavoro in una quota della piattaforma: incentivo legale ad allinearsi.

Compliance = multiplo

Un asset pulito e bancabile vale 7-10x; gli studi grigi 3-4x. La regolarizzazione è l'espansione del multiplo — e il moat.

Ogni clinica rende il gruppo più intelligente



Da roll-up a piattaforma med-tech. Il dataset proprietario di outcome è l'unica cosa che la finanza da sola non compra: nel tempo sposta la valutazione da multiplo *healthcare-services* verso multiplo *AI-platform*. Il medico decide, l'AI misura e supporta — GDPR e sicurezza by design.

La clinica resta medica, la piattaforma fa il resto

Area clinica (per sede)

Direttore sanitario e autorizzazioni per struttura; équipe multi-medico; piena autonomia clinica; comunicazione solo informativa.

Piattaforma di gruppo

M&A e finanza; brand, marketing, percorsi; procurement centralizzato; GM di area, HR, software e KPI.

Comitato scientifico

Indipendente, sopra il CMO: protocolli e audit.

Incentivi $\neq$ volumi

Mai bonus sul venduto: sicurezza e retention.

Audit & mystery patient

Controlli periodici per sede e consulenza.

Soglie reputazionali

KPI con blocco espansione al bisogno.

Cosa compriamo, a quanto, e come strutturiamo

Criteri del target

- ◆ Ricavi 0,8-2,5M, EBITDA 20%+ verificato
- ◆ Bacino 100k+ ab.; cluster regionali (NO, NE, Roma)
- ◆ Base pazienti 1.500+ con iniettabili prevalenti
- ◆ 2+ medici o convertibile a multi-provider
- ◆ Titolare disponibile a permanenza 24-36 mesi

Struttura tipo

- ◆ Prezzo 3-4x EBITDA normalizzato
- ◆ 60-70% cash al closing
- ◆ 15-20% earn-out su risultati a 24 mesi
- ◆ 15-25% rollover equity nella piattaforma
- ◆ Non-compete e patti di permanenza

Pipeline proprietaria

Origination dal network clinico, congressi, fornitori di iniettabili/dispositivi (che conoscono i volumi reali) e advisor di consolidamenti sanitari italiani. Il deal flow migliore non passa dai broker.

ROADMAP

Dal format lab al primo operatore nazionale

FASE 1 · MESI 0-18

Provare il formato

Format lab + prime cliniche nel primo cluster. Uplift EBITDA/clinica. Avvio raccolta dati.

recurring 10%+, EBITDA/clinica +30%

FASE 2 · MESI 18-36

Densità regionale

8-12 cliniche in 2-3 cluster. Playbook 100 giorni, procurement pieno, brand, leva bancaria.

10+ sedi, recurring 20%+, EBITDA 4-6M

FASE 3 · MESI 36-60+

Scala nazionale ed exit

20-30 cliniche + dataset maturo. Target dei consolidatori PE / device-maker.

exit 7-10x, upside med-tech

Il data play matura come layer trasversale: da moat di qualità (Fase 1) a decision-support (Fase 2-3) a opzione di automazione (oltre).

La trasformazione di una clinica tipo in 24 mesi

Clinica tipo	All'acquisto	A 24 mesi
Ricavi	1,20M	1,75M (+45%)
Margine EBITDA	20%	27%
EBITDA	240k	480k

Numeri illustrativi da benchmark, da validare in DD.

Ricavi +45%

Percorsi + recall, mix ampliato, rateizzazione, saturazione col secondo medico.

Margine 20% → 27%

Procurement (sconti volume 10-20%), marketing di gruppo, back office condiviso.

Ritorno sull'acquisizione

Comprata ~3,5x (840k), genera 480k EBITDA a regime: rende già a livello di singola sede.

Chi c'è oggi in Italia e perché lo spazio è vuoto

	Modello	Proprietà	Recurring	Capitale ist.
Clinic Italia	Franchising, ~15 studi	No (affiliazione)	Assente	No
Juneco	Retail centri commerciali	Sì, limitato	Assente	Privati
Studi indipendenti	Mono-medico, artigianale	Sì (titolare)	Assente	No
VENERE	Buy-and-build + format + dati	Sì, rollover medici	Cuore (30%)	Family office + debito

La differenza non è il marketing, è il modello. Nessuno compra cliniche profittevoli, le trasforma con un format a ricavi ricorrenti, allinea i medici con equity e costruisce un dataset. Chi occupa per primo lo spazio diventa il compratore naturale di tutti gli altri.

Visione, AI, clinica, operations — complementari

Luca Martino

FOUNDER & CEO

Imprenditore tech, fondatore e CEO di un gruppo AI enterprise in fase di exit. Visione, capitale, M&A, investitori.

Salvatore Diana

CHIEF AI OFFICER

Architetto della piattaforma agentica e del dataset proprietario: outcome tracking, AI decision-support e la roadmap verso l'automazione. Il moat che la finanza non compra.

Chief Medical Officer

CLINICA

Medico chirurgo estetico: protocolli, format clinico, reclutamento medici e deal flow. Sotto il comitato scientifico indipendente.

COO · AD operativo

OPERATIONS

Reti multi-sede in sanità e consumer premium. Format e P&L per sede, patient journey, integrazione a 100 giorni.

Contrappesi per costruzione: CFO espresso dagli anchor investor; deal team M&A; comitato scientifico indipendente sopra il CMO; consigliere indipendente in board; advisor regolatorio-sanitario, fiscale-M&A e da consolidamenti sanitari italiani già eseguiti.

L'ORIZZONTE

Un asset che l'AI non erode, ma potenzia — e un secondo atto oltre i 10 anni

Non-disruptabile

L'atto medico è fisico, autorizzato, locale. L'AI qui è un tailwind operativo, non una minaccia sul ricavo.

Runway 5-10 anni

Più consolidi, più il multiplo si espande e più diventi il #1 nazionale: la scala lavora a favore.

Oltre: automazione

Il dataset apre la strada all'automazione delle procedure standardizzate: da servizi a med-tech.

VENERE · Riservato e confidenziale

Cosa può andare storto, e come l'abbiamo progettato

Dipendenza dal medico

Multi-provider obbligatorio, rollover ed earn-out sulla permanenza, fedeltà al brand e al percorso.

Regolatorio e deontologico

Struttura MSO, comitato scientifico, comunicazione conforme, advisor regolatorio dal giorno uno.

Qualità dei bilanci target

DD con normalizzazione ricavi, prezzo su EBITDA verificato, earn-out che sposta il rischio sul venditore.

Ciclicità dei consumi

Percorsi ricorrenti che stabilizzano i flussi, rateizzazione, mix a manutenzione ricorrente.

Esecuzione M&A

Playbook 100 giorni nel software, Fase 1 piccola per raffinare il metodo prima di scalare.

Consolidatori esteri

La velocità è la difesa: chi ha già cluster e format diventa la piattaforma da comprare.

Il rischio n°1 resta reputazione e qualità clinica: per questo un intero sistema di governance clinica con soglie di blocco.

Raccolta iniziale: 12 milioni per costruire la piattaforma

70%

Prime 6-8 cliniche (equity +
leva in Fase 2)

15%

Capex del format: offerta,
dispositivi, restyling

10%

Piattaforma centrale:
management, M&A, brand,
software

5%

Riserva operativa e costi di
transazione

Struttura: club deal di family office con governance attiva (board seat e CFO dagli anchor), tranche legate a milestone. Orizzonte 5-6 anni, exit a PE/strategico, target 7-10x EBITDA e MOIC 2,5-3,5x — con upside dal dataset.

Primo passo: commitment sulla **Fase 1 (4-5M)** per le prime cliniche e la prova del format, con prelazione sulle tranche successive.



VENERE

Il primo operatore nazionale della medicina estetica — e la piattaforma di dati che lo rende difendibile nel tempo.

Compriamo cliniche profittevoli, le trasformiamo con un format a ricavi ricorrenti, formalizziamo un settore grigio e costruiamo il dataset che industrializza la qualità. Un mercato grande, senza proprietario, con la finestra aperta.